

2

INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS

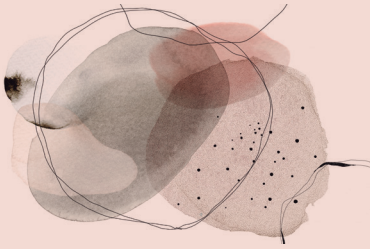
// DR. GUILLERMO PABLO ALARCÓN*

Pediatra Gastroenterólogo y Endoscopista infantil. Hospital Regional Castro Rendon.
La Natividad Policlínico Neuquén. Clínica Cemic - Neuquén.
Docente de la Cátedra de Pediatría. Universidad Nacional del Comahue.
Pro-Secretario Comité Gastroinfantil, Sociedad Argentina de Pediatría.

// DRA. MARIELA ASTONISKA*

Pediatra Gastroenteróloga y Endoscopista. Hospital Juan P. Garrahan.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



FELIPE, 1 AÑO Y 6 MESES

Felipe concurre a la guardia de pediatría, inmediatamente después de que haya sido visto por sus padres cuando se llevaba algo redondeado a su boca para luego tragarlo. Presentó luego de esto, arcadas, náuseas, ahogo y llanto incoercible.

Al ingreso se observa un niño irritable con intensa sialorrea y nauseoso. Los padres refieren que se encontraba en una habitación donde había monedas y muchos juguetes que funcionan con pila botón.

¿Qué conducta asume en este caso?

Después de finalizar la lectura del capítulo, revise su respuesta y compárela con la que figura en la clave de respuestas.

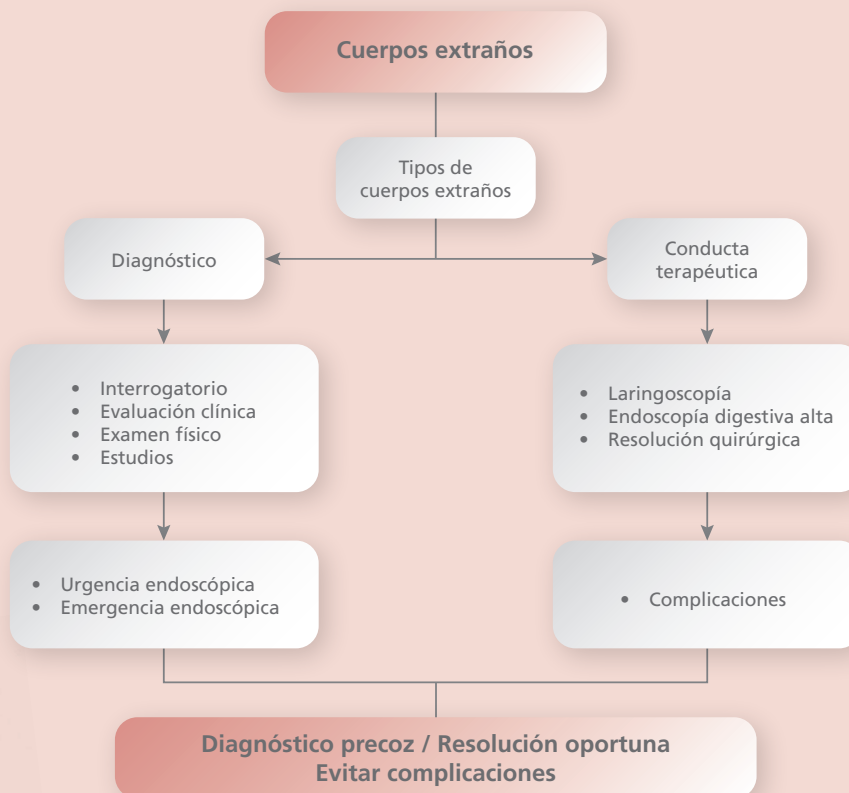


OBJETIVOS

- ◆ Identificar los diferentes tipos de cuerpos extraños ingeridos que pueden significar una urgencia pediátrica con posible resolución endoscópica.
- ◆ Realizar un diagnóstico adecuado.
- ◆ Conocer las posibles complicaciones que se pueden presentar.
- ◆ Determinar el manejo y tratamiento adecuado.
- ◆ Aplicar conducta de prevención de los mismos.

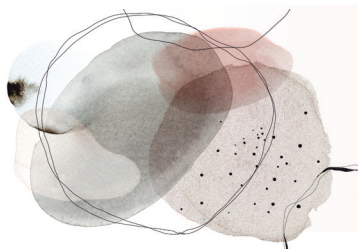
ESQUEMA DE CONTENIDOS

Ingesta de cuerpos extraños



INTRODUCCIÓN

La endoscopía digestiva es una herramienta fundamental en la práctica de la gastroenterología pediátrica; es crucial en el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías como la ingestión de cuerpos extraños. La incidencia de estos eventos es relevante en la población infantil, con riesgos potenciales para la salud.



La urgencia médica en pediatría es una situación que se presenta de forma inesperada que no tiene riesgo inmediato de vida pero que debe ser atendido dentro de las próximas horas, la emergencia requiere de resolución inmediata.

La ingesta de cuerpo extraño (CE) puede comportarse como una urgencia endoscópica pero también como una emergencia y es uno de los motivos de consulta más frecuentes en una guardia de Pediatría General, también es considerado un accidente del hogar. Muchas veces ocurre ante la mirada de sus cuidadores. Con una edad promedio de presentación más frecuente según los diferentes trabajos en menores de 5 años.

El gran porcentaje de los CE son eliminados por materia fecal sin complicaciones de forma espontánea. Entre un 10-20% requiere intervención, generalmente endoscópica y el 1% quirúrgica. La mayoría presenta evolución favorable pero también se han reportado caso de complicaciones que han llevado al óbito del paciente.

Es responsabilidad de los pediatras generales, gastroenterólogos infantiles y emergentólogos que encuentran esta temática cada vez más frecuentemente, tratarla, pero también prevenirla. A pesar de su relevancia solo unas pocas guías se han publicado específicamente para el entorno pediátrico.

TIPOS DE CUERPOS EXTRAÑOS

En un trabajo realizado sobre hallazgos endoscópicos en la guardia de pediatría del Hospital Regional Castro Rendón, Neuquén, Argentina, se analizaron 105 casos, predominantemente en niñas, con una edad promedio de 4,5 años. La mayoría de los casos involucraron ingestión de cuerpos extraños, seguidos por lesiones debidas a ingesta de productos cáusticos y hemorragias digestivas. El día de la semana más común de presentación fue el viernes. Las monedas fueron el cuerpo extraño más frecuente, mientras que las lesiones por productos cáusticos fueron principalmente alcalinas.

La moneda como cuerpo extraño más hallado entre un 70-80% coincide en todos los reportes analizados, independientemente si ésta participe o no de la economía de un país, como sucede en el nuestro. En un segundo lugar, alejado del primero se encuentran, alimentos, juguetes, joyas, huesos, pilas, etc.

Los podemos clasificar en:

Romos. Son los más frecuentes, no tienen extremos punzantes, su tamaño puede determinar el enclavamiento o no. Aunque esto también puede estar determinado por patologías asociadas como la estenosis esofágica, esofagitis eosinofílica, gastroenteropatía eosinofílica o la acalasia, esta última infrecuente en pediatría. Ejemplos: monedas, arandelas, bolo de carne o pilas botón (Figura N°1 y 2).

Figura N°1



Figura N°2



Puntantes. Presentan punta, esta característica determina mayor riesgo de enclavamiento y de perforación. Ejemplos: espinas, agujas, bijoutería, alfileres, tornillos (Figura N° 3).

Figura N° 3



Cortantes. Los bordes filosos generan cortes en la superficie de la mucosa con la cual se puede generar un corte que puede determinar la perforación de la misma. Si es de forma accidental tiende a ser rechazada inmediatamente posterior a la ingesta. Este tipo de CE suelen ser observados en pacientes que intentan autoagredirse. Ejemplos: hojas de afeitar, latas, vidrios.

Complejos. Sus características propias generan mayor capacidad de enclavamiento, perforación, atascamiento y dificultad de extracción con la consiguiente posibilidad de complicaciones y en ocasiones amerita resolución quirúrgica. Ejemplos: dijes, adornos, tenedores.

Pilas. Merece un párrafo aparte que ya desarrollaremos. La mayoría son romas, con el detalle del doble halo en el borde (Figura N°4). El contacto con la mucosa genera injuria por presión, lesión caustica y necrosis. Si está en esófago se considera una emergencia endoscópica.

Figura N°4

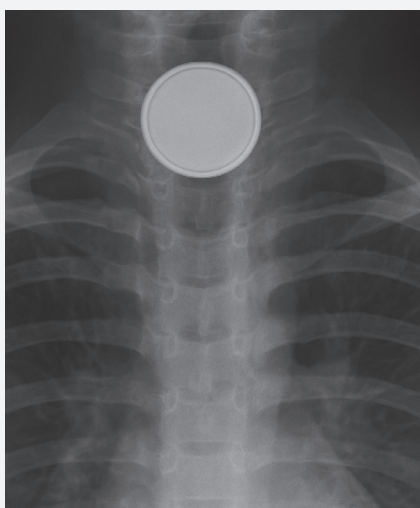
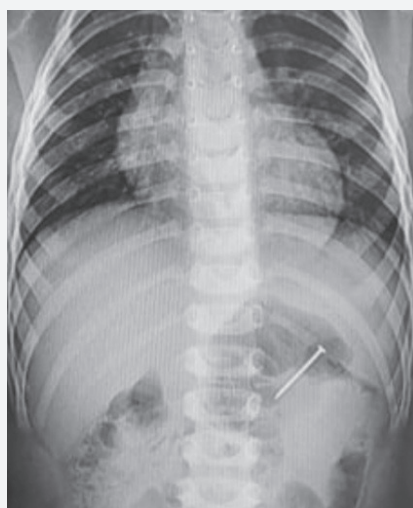


Figura N°5



Tamaño

Es poco probable que los cuerpos extraños mayores de 2 cm de diámetro en menores de 1 año o de 3 cm en mayores de 1 año pasen el píloro. En los cuerpos extraños de más de 6 cm de longitud a cualquier edad, debe considerarse extracción endoscópica (Figura N° 5).

Tabla 1. Tipos de cuerpos extraños según sus características propias

Tipo	Característica	Capacidad de enclavamiento	Capacidad de atascamiento	Capacidad para perforar
Romo	No tiene puntas	Baja	En relación con el tamaño y patología asociada	En relación con el tiempo de presión sobre la mucosa
Punzante	Tiene puntas	Alta	Alta	Alta
Cortante	Tiene filo	Alta	Alta	Alta
Complejos	Estructura no convencional	En relación con el tamaño y la forma	En relación con el tamaño y la forma	En relación con el tamaño y la forma
Pilas botón	No tiene puntas	Baja	En relación con el tamaño y patología asociada	En relación con el tiempo de presión sobre la mucosa

Los **bezoares** suelen tener un tamaño importante que, en ocasiones, resulta difícil extraerlos por vía endoscópica. Un bezoar es la acumulación de sustancias orgánicas dentro del tracto gastrointestinal. El tricobezoar es una acumulación de cabello, generalmente, en las porciones proximales del tracto gastrointestinal y es una enfermedad rara. La formación del tricobezoar comienza con la acumulación de cabello en los pliegues gástricos, el cual es altamente resistente a la digestión y a la peristalsis, debido a su superficie lisa. La ingestión crónica lleva a su agrupación junto con otras sustancias presentes, como moco y alimento, forma un cuerpo extraño que, generalmente, se limita al estómago. En algunos casos, este puede extenderse hasta el intestino o el colon.

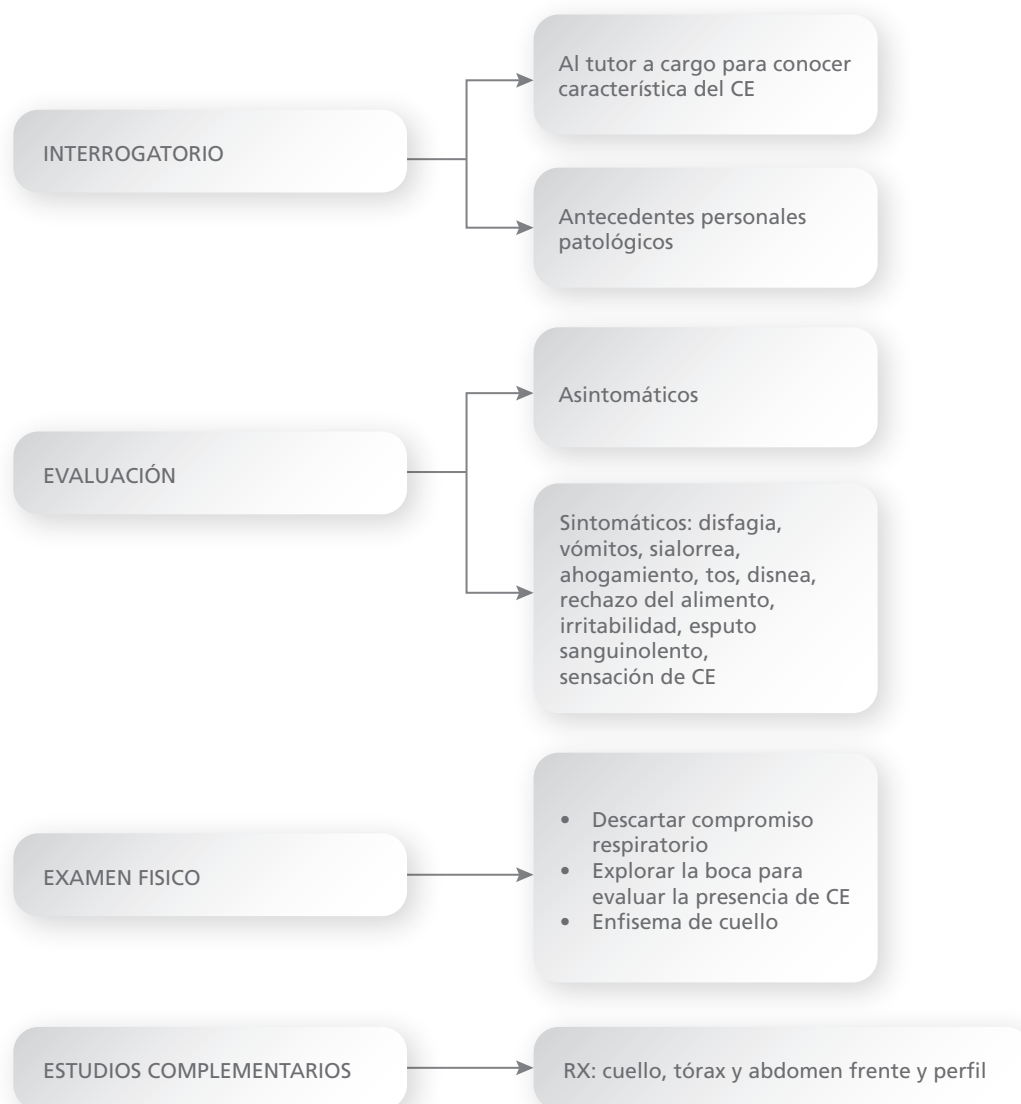
Los materiales que componen los bezoares comprenden material vegetal (fitobezoar), que es el tipo más común de bezoares; restos de frutas (diospirobezoares), que es el subtipo de fitobezoar más común; cabello (tricobezoar) y medicamentos ingeridos (farmacobezoar). Las personas con riesgo de desarrollar esta patología son aquellas con alteraciones anatómicas o en la motilidad gastrointestinal, como pacientes diabéticos, con patologías neurológicas, alteraciones en la secreción de jugo gástrico o con cirugías gástricas previas. Las enfermedades psiquiátricas y el retardo mental se asocian con los bezoares, debido a la pica y a la ingesta compulsiva y excesiva de comida. Los tricobezoares se presentan más en las mujeres, entre las adolescentes y las adultas jóvenes. Pueden permanecer asintomáticos por largos períodos. Los síntomas, típicamente, comprenden zonas de alopecia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, anorexia, saciedad temprana y síntomas relacionados con la anemia, como mareo, palpitaciones y cansancio.

El **tratamiento de los bezoares** no está estandarizado, existiendo tres formas principales: la disolución química, la remoción quirúrgica y la remoción endoscópica. La elección de la forma de tratamiento se basa en el tamaño y la composición del bezoar. El objetivo del tratamiento es su remoción y prevención de la recurrencia que se presenta en 20% de los casos. Vamos a describir la endoscópica y la quirúrgica.

Se utilizan múltiples técnicas para el manejo endoscópico de esta patología con resultados diversos. En la literatura se ha descrito fragmentación y remoción con fórceps, asa de polipectomía (polipectomy snare), water Jet (hidroclisis), láser Nd YAG, litotripsia mecánica, litotripsia electrohidráulica o litotripsia extracorpórea con onda de choque, pero la eliminación endoscópica es tediosa y es necesario contar con endoscopios de canal de trabajo amplio y dependemos fundamentalmente del tamaño del bezoar que cuando genera sintomatología suele ser grande.

La resolución quirúrgica es la elección cuando el bezoar es grande y compacto no permitiendo su extracción por otros medios. Esta puede ser laparoscópica o clásica debiendo tener especial consideración con el síndrome de Rapunzel, en el que son necesarias múltiples enterotomías para la completa remoción del bezoar. Cuando existen complicaciones como perforación o hemorragia, es la vía clásica la vía de elección. Cuando se encuentra asociado a una úlcera no es necesario hacer tratamiento quirúrgico de ésta, ya que al retirar el bezoar mejora la lesión.

DIAGNÓSTICO DE INGESTA DE CUERPO EXTRAÑO



Radiología del cuerpo extraño

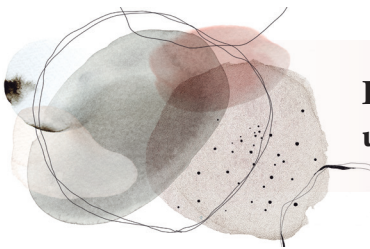
Se deben tomar Rx cuello, tórax, frente y perfil, en algunos centros las proyecciones se realizan con el paciente en decúbito dorsal lo cual permitiría una ubicación más precisa del CE ubicado en cavidad abdominal.

Un 20% de los objetos ingeridos se localizan en el esófago. Hay áreas que fisiológicamente predisponen a su estancamiento, que son el cricofaríngeo (Cervical 6), torácico superior (T1), arco aórtico (T4), bifurcación traqueal (T6), hiato esofágico (T10-T11). Otros sitios de retención en el aparato digestivo son píloro, duodeno, válvula ileocecal y recto.

Un comentario especial muy importante está determinado por la presencia de CE radiolúcidos que suelen estancarse, muy frecuentes en pediatría como son los alimentos (bolo de carne), los juguetes, las espinas y vidrios; ante la presencia de ellos debemos ayudarnos con la clínica y el interrogatorio al tutor del niño.

Es de extrema importancia saber leer e interpretar la placa porque la misma determina nuestra conducta, no reviste dificultad cuando se encuentra en esófago, pero si cuando paso el esfínter esofágico interior y tenemos que determinar si se encuentra en estómago o en que segmento de intestino, para evaluar la posibilidad de utilizar el endoscopio para su extracción.

MANEJO



Lo primero a considerar por el endoscopista es si se trata de una emergencia o una urgencia endoscópica.

Esto dependerá de la edad del paciente, clínica, característica y tamaño del cuerpo extraño. Lugar de atascamiento y tiempo desde la ingesta, esto determina el grado de la lesión de la mucosa esofágica.

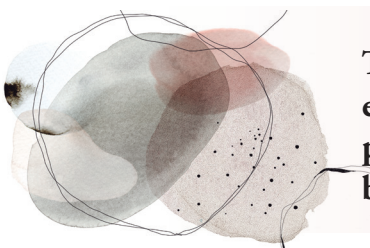
Momentos para la extracción endoscópica

Inmediatos: aquellos pacientes que presentan compresión extrínseca de la vía aérea y el CE se encuentra en esófago y la ingestión de pila botón.

Diferido: sin ayuno, asintomáticos y que no obliguen a realizar un estudio inmediato.

Conducta expectante: CE romos, pequeños y que haya atravesado píloro. Se controlará su progresión mediante Rx seriadas y su eliminación por vía natural.

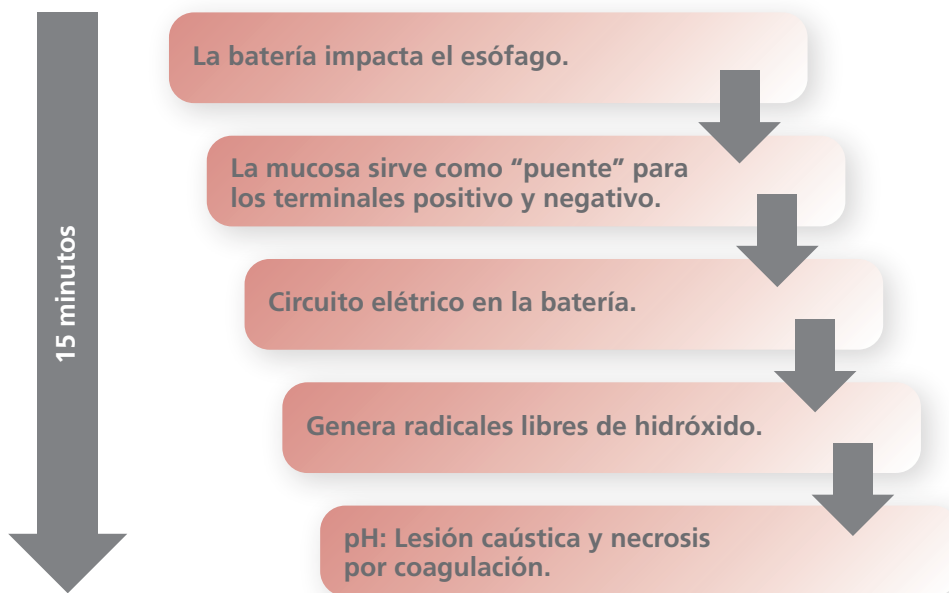
Emergencia	Menos de 4 horas
Urgencia	Menos de 24 horas
Electiva temprana	Menos de 48 horas
Electiva	Más de 48 horas



Todo cuerpo extraño localizado en esófago debe ser extraído antes de la 24 h de la ingestión porque genera lesión por decúbito y riesgo de perforación. La extracción de pila botón es inmediata.

PILAS BOTÓN - BATERÍAS MONEDAS

Constituye un capítulo aparte ya que produce lesión por compresión y porque por su naturaleza se comporta como un caustico alcalino. El alto riesgo de complicaciones que puede causar su ingestión lleva a que su extracción sea en tiempos más cortos. Si está en esófago constituye una emergencia endoscópica y debe ser extraída de forma inmediata, inclusive, sin tener ayuno. Si se encuentra en estómago se asume como una urgencia endoscópica y debe ser extraída en las primeras 24 horas. Si se encuentra más allá de píloro se debe hacer seguimiento radiológico.



Baterías

- Las pilas de botón (o baterías moneda) generalmente tienen 1,5 V a 3,0 V. Las pilas alcalinas llegan a 1,5 - 1,6 V.
- Complicaciones más graves en niños < 5 años.
- Radiografía de tórax frente y perfil, cervical y abdomen.
- Evaluar la topografía por encima de la clavícula.
- En el esófago, incluso con poco daño en la endoscopia, puede haber complicaciones tardías graves.

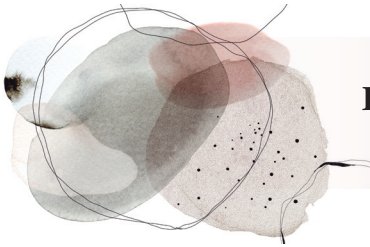
Posterior a la extracción de la pila, el niño debe ser observado por posibles complicaciones:

- Fístulas traqueoseofágicas.
- Perforación de esófago.
- Parálisis de las cuerdas vocales.
- Lesión del nervio recurrente.
- Mediastinitis.
- Neumotórax.
- Neumonía por aspiración.

Tabla 2. Mecanismo de acción según el tipo de agente

Características	Ácidos	Álcalis
Físicas	Amargos, causan dolor de inmediato, y el reflejo protector impide su deglución masiva.	Insípidos e inodoros. Deglutidos antes de que aparezca el reflejo protector.
Efecto	Necrosis por coagulación con formación de escaras que limitan la penetración.	Necrosis por licuefacción de los tejidos, trombosis vascular. Difusión a capas profundas. Riesgo de perforación.
Sitio de lesión más frecuente	Estómago, antro pilórico.	Orofaringe y esófago.
pH capaz de producir lesión	4 o <	12 o >
Sustancias más comunes	Ácidos muriático, sulfúrico, acético y bórico.	Soda cáustica, lavandina, limpiahornos, destapa cañerías y amoníacos.

Fuente: Dres. Inés Ninomiya, Gustavo Aliverti, María de los Ángeles Valdez Suárez, Valeria Taire, Carolina Riga. Consenso Urgencias Endoscópicas. Arch Argent Pediatr 2017;115 Supl 1: S1



La causa más común de muerte es la fistula traqueoesofágica

El principal mecanismo de lesión es la hidrólisis y la producción de iones de hidróxido, esta aumenta rápidamente el entorno del tejido circundante a un PH de 12 a 13. Actúan con un pH igual a 12 o mayor. Producen necrosis por licuefacción, desnaturalización de las proteínas, saponificación de las grasas y trombosis vascular.

Son bilaminares observándose en la radiografía de frente la presencia de un doble halo o contorno mientras que en el perfil se puede observar un sector con una ligera protuberancia, siendo este el signo del escalón y correspondiendo al polo negativo de la pila (ánodo).

Se distinguen 4 fases evolutivas:

1ª fase: aguda del 1º al 2º día, es cuando se produce la necrosis con saponificación, trombosis vascular e intensa reacción inflamatoria. Por eso, en esta fase, debe efectuarse el diagnóstico, sentar el pronóstico e iniciar las medidas terapéuticas.

2ª fase: subaguda del 3º al 5º día, está caracterizada por la exulceración.

3ª fase: reparación del 6º al 14º día, se inician los fenómenos reparadores; el edema inflamatorio es sustituido por tejido de granulación. En este momento, la pared es muy débil y no debe ser manipulada para evitar complicaciones.

4ª fase: cicatrización o crónica del 15º al 30º día, aunque puede prolongarse hasta el 45º día; se va consolidando la cicatrización y es aquí cuando se establece la estenosis esofágica. Cuanto más grave es la quemadura, mayor puede ser la estenosis.

Para evaluar las lesiones que se observaron en la endoscopia utilizamos la clasificación de Zargar.

Clasificación de Zargar:

- Grado 0: mucosa normal.
- Grado I: edema e hipertermia de la mucosa.
- Grado IIa: ulceraciones superficiales, erosiones, exudados, ampollas, hemorragias.
- Grado IIb: ulceraciones profundas circunscriptas, úlceras circunferenciales.
- Grado IIIa: necrosis focal.
- Grado IIIb: necrosis extensa.

Complicaciones

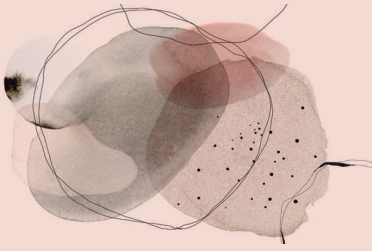
Perforación espontánea. Es una posibilidad con el tiempo de contacto entre la pila botón (PB) y la mucosa.

Perforación instrumental endoscópica: en el momento de la extracción de la PB se puede generar perforación del esófago debido a que la PB genera una adherencia sobre la mucosa. Se debe extraer con mucho cuidado con el material adecuado y utilizando mucha cantidad de agua para separarlos.

Estenosis en la fase crónica: todos los pacientes con quemaduras esofágicas significativas (grado II a o superior) deben ser evaluados con un esofagograma de bario para observar la formación de estenosis. El estudio debe realizarse de dos a tres semanas después de la ingestión o antes si el paciente desarrolla disfagia (dificultad para tragar), lo que sugiere obstrucción esofágica. La estenosis pilórica se puede presentar después de la 3ª semana hasta las 10 semanas de ingestión. La derivación quirúrgica puede ser necesaria, pero la dilatación endoscópica con balón también ha sido utilizada con éxito.

Metaplasia y carcinoma esofágico: el riesgo de desarrollar metaplasia y carcinoma es mayor en estos pacientes que en población general (se reportó hasta en el 2% de los casos). El período de latencia puede ser muy prolongado (entre 13 y 42 años). El intervalo medio entre la exposición al cáustico y el desarrollo de cáncer es de aproximadamente 40 años.

Perforación postdilatación. Se recomienda realizar controles endoscópicos, que deben comenzar luego de 15 a 20 años de la ingesta del cáustico.



Autoevaluación

I. Identifique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados.

	V	F
1. Los diferentes reportes identifican que los pequeños juguetes o piezas de estos son los cuerpos extraños más frecuentemente hallados.	☐	☐
2. En los cuerpos extraños de más de 6 cm de longitud a cualquier edad debe considerarse extracción endoscópica.	☐	☐
3. El tratamiento de elección de los bezoares es la remoción endoscópica.	☐	☐
4. En los pacientes con ingestión de pilas botón y los que presentan compresión extrínseca de la vía aérea y el CE se localiza en esófago se debe realizar la extracción endoscópica de manera inmediata.	☐	☐
5. Las pilas botón se deben extraer con el material adecuado y utilizando mucha cantidad de agua.	☐	☐

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

CAMILA 2, AÑOS

Camila concurre a la guardia de pediatría llevada por su madre, porque refiere que mientras la estaba peinando, le entrega 2 accesorios para sujetar el pelo a la nena para que se los tenga y segundos después solo tenía uno en su mano, cuando su madre le pregunta porque tenía uno solo, ella le dice que se lo tragó. A la madre no le sorprende porque ya le había sucedido esta situación, ya que la pequeña tiene el hábito de llevarse elementos a la boca y tragárselo, anteriormente había sucedido con terrones de tierra y papeles. El pediatra le dijo que esto se llamaba hábito de pica y que es normal en el desarrollo evolutivo de los niños pero que lo tuviera en cuenta porque se lo puede vincular con anemia. En esta oportunidad la madre la lleva a la guardia porque la nena presenta salivación intensa y dolor de garganta. ¿Qué conducta asume en este caso?

.....

VALENTINA, 14 AÑOS

Valentina está siendo evaluada por Servicio de Salud Mental del Hospital por tener trastornos de la conducta alimentaria. La madre dice que tiene la costumbre de comerse el pelo desde hace años. Desde hace 48 horas presenta vómitos incoercibles e intenso dolor abdominal. ¿Qué conducta asume en este caso?

.....

CONCLUSIONES

La ingestión de cuerpos extraños es frecuente en la población pediátrica y en ocasiones no surge claramente a la anamnesis por lo que hay que tener un alto índice de sospecha ante signos como atragantamiento, salivación o disfagia.

Ante la sospecha se debe recurrir a exámenes complementarios como Rx que visualizan objetos radiolúcidos y pueden diferenciar entre la ingestión de monedas o pilas botón, ya que las conductas terapéuticas son diferentes.

Es importante que el pediatra tenga en cuenta los objetos que constituyen una emergencia, una urgencia o requieren un tratamiento diferido o conducta expectante.

En todas las consultas de control en salud es necesario compartir con las familias las prácticas orientadas a la prevención de lesiones no intencionales insistiendo, según la edad del niño, en el cuidado con los objetos pequeños, las monedas o botones, los juguetes con pilas o los que tienen piezas pequeñas.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Consenso Urgencias endoscópicas. Arch Argent Pediatr 2017;115(1):96-98
<https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n1a29.pdf>
- Alarcón, G. P., Lamot, J., Dieguez, A., Palas, C., Llambi, J., & Farias, A. (2024). Hallazgos endoscópicos en los procedimientos realizados en una guardia de pediatría: Experiencia de un hospital de alta complejidad de la Patagonia Argentina. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, 54(1), 79–83.
<https://actagastro.org/numeros-anteriores/2024/Vol-54-N1/Vol54N1-PDF11.pdf>
- Maluenda Carrillo C, Varea Calderón V, Bodas Pinedo A. Ingesta de cuerpos extraños. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Ergón S.A; 2010
<https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/16-cextranos.pdf>
- Sethia R, Gibbs H, Jacobs IN, Reilly JS, Rhoades K, Jatana KR. Current management of button battery injuries. Laryngoscope Investig Otolaryngol. 2021 Apr 15;6(3):549-563. doi: 10.1002/lio2.535. PMID: 34195377; PMCID: PMC8223456. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34195377/>
- Lerner DG, Brumbaugh D, Lightdale JR, Jatana KR, Jacobs IN, Mamula P. Mitigating Risks of Swallowed Button Batteries: New Strategies Before and After Removal. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 May;70(5):542-546. doi: 10.1097/MPG.0000000000002649. PMID: 32022776. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32022776/>
- Akbar S, Akbar L, Akbar N, Nawras A. Trichobezoar Induced Heartburn in a Teenage Girl: A Case Report. J Investig Med High Impact Case Rep. 2018; 6:2324709618776345. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29796396/>

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Identifique verdadero (V) o falso (F) en los siguientes enunciados.

1. **Falso.** En la mayoría de los casos es la moneda es el cuerpo extraño más frecuentemente hallado.
2. **Verdadero.**
3. **Falso.** El tratamiento de los bezoares no está estandarizado, existiendo tres formas principales: la disolución química, la remoción quirúrgica y la remoción endoscópica. La elección de la forma de tratamiento se basa en el tamaño y la composición del bezoar.
4. **Verdadero.**
5. **Verdadero.**

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

FELIPE, 1 AÑO Y 6 MESES

Se le pregunto a los padres que, si vieron lo que ingirió, si fue un único objeto, si es la primera vez que esto sucede, si estaba solo en el momento, si tiene una patología previa y si tiene horas de ayuno.

Los padres refieren que creen que fue una moneda porque el hermano dijo que tenía varias monedas en la mano. También se fijaron si a los juguetes les faltaba alguna pila y no. Es la primera vez que esto sucede, siempre están pendiente del niño porque saben que los accidentes del hogar son frecuentes a esta edad, así se los hizo saber su pediatra en el control de niño sano. No tiene antecedentes patológicos previos como para que generen una detención del CE por el tracto digestivo. No tiene ayuno. Se le realiza un Rx toracoabdominal (Figura N° 6) donde se observa en tercio superior, imagen radio opaca, redonda, uniforme, sin signo del doble halo. Impresiona grande para la anatomía del niño.

A pesar de estar con sialorrea y mucho dolor, desde anestesia se decide esperar las horas de ayuno, por el riesgo que genera la broncoaspiración al momento de la intubación.

El procedimiento se realizó a las 8 h de la ingesta y se realizó la extracción mediante pinza de cocodrilo y luego de la extracción en el second look se observó erosiones por apoyo del CE sobre la mucosa. (Figura N°7)

Figura N°6

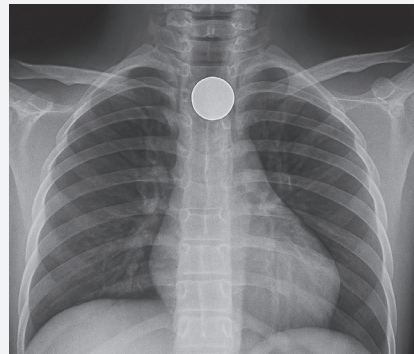
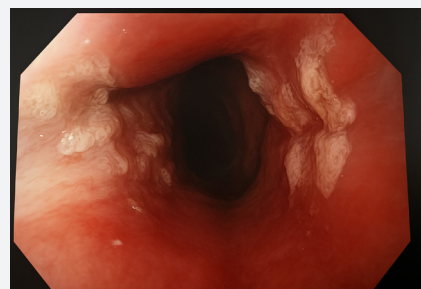


Figura N°7

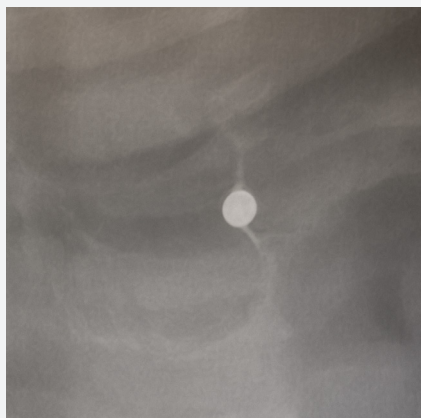


Discusión: Si bien la moneda no genera las complicaciones que genera una pila boton, el hecho de la edad del niño, la anatomía vinculada con el cuerpo extraño y la sintomatología deben asumir este caso, como una emergencia endoscópica y no respetar el ayuno.

CAMILA 2, AÑOS

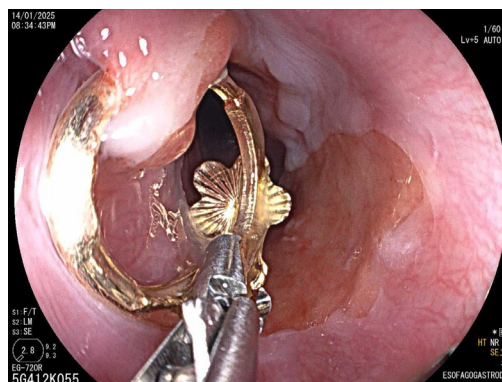
La niña tiene la costumbre introducirse elementos en su boca, su pediatra le dijo que esto obedece al habito de pica. No presenta anemia y ningún otro antecedente. La madre dice que falta un elemento de peinado (hebilla), nos trae un similar que es de plástico, con puntas redondeadas y pequeño Rx (Figura 8).

Figura N°8



Discusión: Muchas veces a la forma del cuerpo extraño, la posición y la naturaleza del mismo hacen que no corresponda la imagen de la rx con la realidad del mismo (Figura 8). Debido a eso siempre tenemos que estar preparados, con distintos elementos de extracción: pinzas, canastas, capuchones, etc. (Figura N° 9), y atentos a las complicaciones, como lesión de la mucosa generada por el enclavamiento del cuerpo extraño.

Figura N° 9



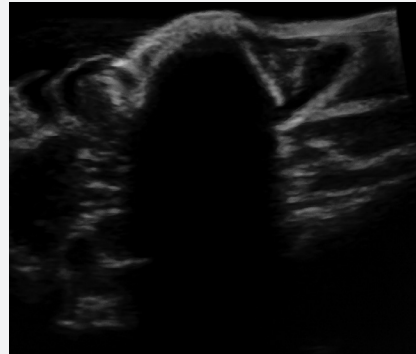
VALENTINA, 14 AÑOS

Debido a los antecedentes, tricofagia y de los síntomas actuales, dolor abdominal y vómitos, se realiza ecografía abdominal donde se observa imagen compatible con tricobezoar, localizada en región del píloro (Figura N°10). Motivo por el cual se solicita endoscopia digestiva alta observándose tricobezoar en zona de píloro (Figura 11).

Tricobezoar en niña de 14 años a la cual se le realizaron distintos procedimientos para reducir su tamaño con resultados negativos. Se le extrajo por vía quirúrgica.

Se intentó remoción química para disminuir el tamaño, sin obtenerse respuesta y luego vía endoscópica con cortes mediante electrobisturí con mismos resultados. Se extrajo finalmente por vía quirúrgica.

Discusión: En pacientes con trastornos conductuales y certeza de tricofagia se debe actuar de forma precoz para realizar el diagnóstico prematuro con la posibilidad de que este sea pequeño y pueda extraerse por vía endoscópica.

Figura N°10**Figura N°11**